

Asma · crise e status asmático

Na crise asmática, classifique gravidade pela fala, FR, SatO₂ , e pico de fluxo. SABA + corticoide sistêmico são a base; magnésio e VNI/IOT entram na crise grave/status.

Corticoide — não atrase

Dica - Corticoide — não atrase

Prednisona/prednisolona VO ou hidrocortisona/metilprednisolona EV na crise moderada-grave. O efeito não é imediato — inicie cedo.

Triagem rápida: fala e SatO₂ , orientam intensificação; silêncio auscultatório e sonolência são sinais de alarme.

Gravidade da crise asmatica

Leve-moderada / grave / iminencia de PCR

Leve-moderada

Fala frases
SatO₂ $\geq$ 92-94%
SABA +/- SAMA + corticoide

Observar resposta

Grave

Fala palavras
SatO₂ < 92% / PFE baixo
O₂ + SABA contínuo + MgSO₄

Internacao

Iminencia de PCR

Sonolencia / silencio
Bradipneia / cianose
IOT + UTI

Emergencia

Escalonamento

- SABA (salbutamol) seriado ou contínuo; associar ipratrópio na grave
- O₂ , para SatO₂ , alvo (~94–98% no asmático sem DPOC)
- Sulfato de magnésio EV na crise grave com má resposta
- Evitar sedação superficial fora de ambiente preparado para IOT

Sinais de alarme

Sinal | Significado

Silêncio auscultatório | Obstrução extrema

Normo/hipercapnia na crise | Fadiga — risco de PCR

Uso de acessórios + tiragem | Trabalho ventilatório alto

FC muito alta / hipotensão | Gravidade / complicação

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

PaCO₂ , 'normal' na crise grave não é tranquilizador — pode indicar fadiga muscular iminente. Melhora clínica e PFE/SatO₂ , valem mais que um único gás 'bonito'.